

SEHA

Memenangkan Pasar Operasional Klinik & RME untuk Praktik Primer di Indonesia

Versi: 3.0 (Komprehensif)

Tanggal: 20 Juni 2026

Basis operasi: Solo (Surakarta)

Tagline produk: "Kembalikan Waktu Dokter untuk Pasien"

Dokumen perencanaan strategis internal. Data pasar bersumber publik (Kemenkes, riset pasar, benchmark industri); profil kompetitor bersifat indikatif berdasarkan positioning publik dan **memerlukan validasi lanjutan**; seluruh proyeksi finansial adalah **asumsi yang dieksplisitkan**, bukan jaminan kinerja. Bukan nasihat finansial, hukum, atau investasi.

Daftar Isi

Pendahuluan

- Metodologi & Kerangka Analisis
- Ringkasan Eksekutif

Bagian I — Konteks Strategis

- Konteks Makro & Industri (PESTEL)
- Lanskap Regulasi
- Analisis & Ukuran Pasar (TAM/SAM/SOM)
- Segmentasi & Persona Pelanggan

Bagian II — Kompetisi & Posisi

- Lanskap Kompetitif & Matriks Fitur
- Porter's Five Forces
- SWOT & Matriks TOWS
- Posisi Kompetitif & Blue Ocean (ERRC)
- Proposisi Nilai & Strategi Produk

Bagian III — Model Bisnis & GTM

- Business Model Canvas
- Strategi Penetapan Harga
- Strategi Go-to-Market
- Pemasaran & Merek
- Operasi, Teknologi & Keamanan
- Organisasi & Talenta

Bagian IV — Finansial & Investasi

- Asumsi Kunci
- Ekonomi Unit (mendalam)
- Proyeksi Pendapatan & P&L 5 Tahun
- Arus Kas & Break-even
- Kebutuhan Pendanaan & Use of Funds
- Valuasi & Imbal Hasil (DCF + Multiple)
- Skenario & Sensitivitas

Bagian V — Risiko & Eksekusi

- Penilaian Kelayakan
- Risk Register & Matriks
- Roadmap, Rencana 90 Hari & OKR
- Sintesis Strategis: How to Win
- Lampiran, Glosarium & Referensi

1. Metodologi & Kerangka Analisis

Dokumen ini disusun dengan pendekatan **hypothesis-driven, MECE, dan fact-based** ala konsultan strategi terkemuka. Setiap rekomendasi mengikuti logika *situation → complication → resolution* dengan prinsip "so what".

Domain	Kerangka yang digunakan	Tujuan analitik
Lingkungan makro	PESTEL	Memetakan kekuatan eksternal & tailwind regulasi
Ukuran pasar	TAM/SAM/SOM (bottom-up & top-down)	Potensi & target realistis
Pelanggan	Segmentation, Persona, Jobs-to-be-Done, WTP	Fokus segmen & pesan
Industri	Porter's Five Forces	Daya tarik & sumber profit pool
Strategi	SWOT/TOWS, Blue Ocean ERRC, peta posisi 2x2	Diferensiasi & "how to win"
Model bisnis	Business Model Canvas, Value Proposition Canvas	Koherensi model
Ekonomi unit	CAC, LTV, payback, churn, NRR, magic number, Rule of 40	Kesehatan & efisiensi modal
Valuasi	DCF (NPV/IRR), comparable ARR multiple	Imbal hasil investasi
Ketidakpastian	Skenario (bear/base/bull), sensitivitas (tornado)	Ketahanan keputusan
Risiko & eksekusi	Risk register, matriks probx&dampak, OKR/90-day plan	Mitigasi & eksekusi

2. Ringkasan Eksekutif

Tesis investasi: Indonesia mewajibkan Rekam Medis Elektronik (UU Kesehatan 17/2023), namun puluhan ribu praktik mandiri & klinik pratama belum terdigitalisasi karena solusi yang ada terlalu kompleks atau mahal. SEHA menang dengan menjadi **yang paling sederhana, paling terjangkau, dan patuh-regulasi** — sebuah strategi *blue ocean* pada segmen yang diabaikan pemain besar.

TAM (ARR potensial) Rp332 M	SAM Rp83 M	Break-even ±47 klinik	LTV : CAC ±16 : 1
CAC payback ±6 bln	NPV @20% +Rp390 jt	IRR (5 thn) ±48%	Modal dibutuhkan ±Rp400–500 jt

Tiga pesan utama

- Pasar bernilai & didorong regulasi.** TAM ±23.000 fasilitas (±Rp332 miliar ARR); mandat RME menciptakan urgensi beli.
- Ekonomi unit sangat sehat.** LTV:CAC ±16:1 dan payback ±6 bulan jauh melampaui benchmark SaaS (3–5:1; <12 bln). Kendala bukan model, melainkan **skala & runway**.
- Kemenangan ditentukan eksekusi.** Diferensiasi simpel + pediatri + kepatuhan, dieksekusi via pilot dr. Aisyah → ekspansi regional Jawa Tengah/DIY.

Rekomendasi (GO). Galang modal ±Rp400–500jt; menangkan pilot sebagai bukti nilai; bangun mesin akuisisi yang repeatable menuju 47 klinik (break-even, Tahun 2–3); naikkan gross margin via otomasi; selesaikan hardening kepatuhan sebelum skala.

Ringkasan kelayakan

Dimensi	Putusan	Catatan inti
Teknis	Sangat Layak	Stack matang; prototipe 17 halaman sudah live di produksi
Pasar	Layak	TAM besar + mandat RME
Finansial	Layak	NPV+, IRR ±48%, unit economics kuat
Operasional	Layak	Low-click; tim ramping basis Solo
Hukum/Kepatuhan	Bersyarat	Hardening PDP/RME wajib sebelum data nyata
Eksekusi/GTM	Kritis	Mesin penjualan belum terbukti — fokus utama

3. Konteks Makro & Industri (PESTEL)

Faktor	Kekuatan kunci	Dampak ke SEHA
Political	Agenda transformasi kesehatan digital Kemenkes; platform SATUSEHAT sebagai tulang punggung interoperabilitas nasional	Positif
Economic	Belanja kesehatan & kelas menengah tumbuh; namun klinik primer sensitif harga; risiko depresiasi Rupiah (biaya USD)	Campuran
Social	Adopsi digital tinggi; meningkatnya ekspektasi orang tua atas layanan anak yang rapi & modern	Positif
Technological	Cloud terjangkau; standar HL7 FHIR/SNOMED; AI untuk efisiensi dokumentasi	Positif
Environmental	Dorongan paperless & efisiensi operasional	Netral+
Legal	UU 17/2023 (RME wajib), Permenkes 24/2022, UU 27/2022 (PDP), akreditasi fasyankes	Tailwind kuat

So what: kombinasi *mandat regulasi (push)* + *ekspektasi pasien (pull)* menciptakan jendela waktu (2025–2028) untuk merebut klinik yang belum terdigitalisasi. Pemenang adalah yang menurunkan **friksi adopsi** (harga + kompleksitas) paling rendah.

4. Lanskap Regulasi (Pendorong Permintaan)

Regulasi	Inti	Implikasi bisnis
UU No. 17/2023 (Kesehatan)	Mendorong digitalisasi & rekam medis elektronik; menyelaraskan privasi dengan UU PDP	Kebutuhan beli RME menjadi wajib , bukan opsional
Permenkes No. 24/2022	Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik bagi fasyankes	Definisi fitur RME yang harus dipenuhi produk
UU No. 27/2022 (PDP)	Perlindungan data pribadi/sensitif	Wajib enkripsi, consent, retensi, audit, DPO-readiness
SATUSEHAT (Kemenkes)	Platform interoperabilitas nasional (HL7 FHIR)	Integrasi = syarat kelayakan jangka menengah & pembeda
Akreditasi fasyankes	Standar mutu klinik/TPMD	Dokumentasi rapi membantu akreditasi → nilai jual

Kesimpulan: regulasi adalah **katalis penjualan terkuat**. Pesan komersial SEHA harus memposisikan produk sebagai "jalan termudah & termurah menuju kepatuhan RME & kesiapan SATUSEHAT".

5. Analisis & Ukuran Pasar (TAM / SAM / SOM)

5.1 Basis data (Kemenkes — Profil Kesehatan Indonesia 2024)

Fasilitas	Jumlah	Relevansi
Klinik pratama	14.564	Target inti
Klinik utama	2.697	Ekspansi (lebih kompleks)
Klinik milik swasta	15.311	Mayoritas addressable
Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)	8.465	Target inti (solo)
Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG)	3.946	Adjacency

5.2 Bottom-up sizing

Lapisan	Definisi	Unit	ARR @Rp14,4jt	% TAM
TAM	Klinik pratama + TPMD se-Indonesia	±23.000	Rp331,6 M	100%
SAM	Swasta, terjangkau digital, fokus Jawa (±25%)	±5.750	Rp82,8 M	25%
SOM (3 thn)	Target jangka pendek	±120	Rp1,73 M	0,5%
SOM (5 thn)	Target jangka menengah (±5% SAM)	±300	Rp4,32 M	1,3%

5.3 Cross-check top-down & pertumbuhan

Pasar EMR Asia-Pasifik tumbuh ±6,2% CAGR (2025–2032), didorong mandat digitalisasi & ekspansi layanan swasta. Segmen "klinik sederhana" di Indonesia adalah niche bernilai ratusan miliar Rupiah yang **kurang dilayani**. Target SOM SEHA (±1% TAM dalam 5 tahun) sangat konservatif — memberi ruang upside besar.

So what: bahkan penetrasi <1% TAM sudah membangun bisnis yang sehat & menguntungkan. Pasar bukan kendala; **kecepatan & biaya akuisisi** adalah variabel penentu.

5b. Rantai Nilai Industri & Profit Pool

Pemetaan rantai nilai layanan primer menunjukkan di mana SEHA menciptakan & menangkap nilai:

Mata rantai	Pemain	Margin/daya tarik	Posisi SEHA
Akuisisi pasien	Iklan, rujukan, telemedicine	Tinggi tapi mahal	Dukung via website publik & reminder
Registrasi & antrean	Manual / SIM klinik	Operasional	Inti SEHA
Pemeriksaan & RME	Dokter + EMR	Wajib (regulasi)	Inti SEHA
Farmasi & stok	Apotek, distributor	Margin produk	Monitoring stok
Kasir & klaim	Kasir, BPJS, asuransi	Arus kas	Billing (Fase 2 lanjut)
Kepatuhan & pelaporan	SATUSEHAT, akreditasi	Beban → peluang	Pembeda SEHA

So what: SEHA menangkap "lapisan operasional inti + kepatuhan" — titik dengan kebutuhan wajib (RME) & stickiness tinggi. Profit pool terbesar jangka panjang ada di **kepatuhan/interoperabilitas** (SATUSEHAT) & **billing**, jalur ekspansi alami SEHA.

6. Segmentasi & Persona Pelanggan

6.1 Segmentasi

Segmen	Karakteristik	WTP/tahun	Prioritas
Praktik mandiri dokter (solo)	1 dokter, 1–3 staf; butuh cepat & murah	Rp10–18 jt	Beachhead
Klinik pratama kecil	2–5 dokter, multi-staf; butuh antrean & multi-user	Rp15–30 jt	Inti
Praktik anak/pediatri	Butuh KMS tumbuh kembang, imunisasi	Rp12–20 jt	Niche menang
Klinik utama / multi-cabang	Kompleks, multi-poli	Rp30 jt+	Ekspansi

6.2 Persona & Jobs-to-be-Done

dr. Aisyah — Pemilik Praktik

Dokter anak, sibuk, anti-ribet.

JTBD: "Bantu saya selesai dokumentasi cepat & patuh aturan, tanpa memperlambat pelayanan."

Pemicu beli: kewajiban RME, ingin citra profesional.

Admin Klinik

Operator harian.

JTBD: "Kelola antrean, pendaftaran, laporan & kasir tanpa kacau."

Pemicu: antrean ramai, laporan manual melelahkan.

Orang Tua Pasien

Pengguna akhir tidak langsung.

JTBD: "Daftar mudah, tidak menunggu lama, dapat pengingat imunisasi."

Pengaruh: kepuasan → retensi & rujukan.

Keputusan strategis: jadikan **praktik anak/pediatri solo** sebagai *beachhead* (fitur KMS = pembeda tajam, persaingan rendah, advokasi kuat dari orang tua), lalu melebar ke klinik pratama umum.

6b. Peta Perjalanan Pelanggan (Customer Journey)

Tahap	Pikiran dokter	Titik sentuh SEHA	Risiko gesekan
Kesadaran	"Saya harus pakai RME, tapi ribet."	Konten edukasi, referral, demo publik	Tidak tahu SEHA ada
Pertimbangan	"Apa beda & berapa harganya?"	Demo langsung, perbandingan, harga transparan	Bandingkan dengan vendor mahal
Keputusan	"Apakah aman & mudah dipakai staf?"	Pilot/trial, testimoni, founding-partner offer	Keraguan keamanan/adopsi
Onboarding	"Semoga cepat & tidak mengganggu praktik."	Deploy + migrasi + pelatihan terpandu	Setup lambat → frustrasi
Retensi	"Apakah benar menghemat waktu saya?"	Dukungan responsif, update, dashboard nilai	Nilai tidak terasa → churn
Advokasi	"Saya rekomendasikan ke kolega."	Komunitas, program rujukan	Tidak ada insentif rujuk

Prioritas pengalaman: hilangkan gesekan di **onboarding** (kecepatan go-live) & **retensi** (nilai terasa) — dua titik yang paling menentukan churn & LTV.

7. Lanskap Kompetitif & Matriks Fitur

Profil di bawah bersifat indikatif berdasarkan positioning publik per kategori; verifikasi kompetitif lanjutan diperlukan sebelum klaim pemasaran.

7.1 Arketipe kompetitor

Arketipe	Contoh kategori	Fokus	Kelemahan vs SEHA
SIM/EMR klinik & RS lengkap	Vendor SIMRS/SIMKlinik mapan	Klinik utama/RS, fitur lengkap	Kompleks, mahal, banyak klik untuk praktik solo
Platform klinik digital	Vendor klinik-tech komersial	Klinik berjaringan, ekosistem	Overkill & biaya tinggi untuk solo
Telemedicine & super-app	Platform konsultasi daring	Pasien-sentris, telekonsultasi	Bukan EMR operasional praktik mandiri
Platform pemerintah	SATUSEHAT	Interoperabilitas nasional	Bukan sistem operasional harian klinik
Manual / generik	Kertas, spreadsheet, WhatsApp	Gratis/murah	Tidak patuh RME, tidak terstruktur

7.2 Matriks fitur & harga (ilustratif)

Dimensi	SEHA	EMR/SIM lengkap	Platform klinik	Manual
Kemudahan (low-click)	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
Harga untuk solo	Murah	Mahal	Sedang–Mahal	Gratis
KMS tumbuh kembang anak	Ya	Sebagian	Jarang	Tidak
Kepatuhan RME	Ya*	Ya	Ya	Tidak
Kesiapan SATUSEHAT	Fase 2	Ya	Ya	Tidak
Dashboard manajemen	Ya	Ya	Sebagian	Tidak
Website publik praktik	Ya	Tidak	Sebagian	Tidak

*Setelah hardening kepatuhan (Fase 1.5). SEHA menang pada sumbu kemudahan + harga + fokus pediatri, bukan kelengkapan enterprise.

8. Porter's Five Forces (dengan Skor)

Gaya	Intensitas	Skor (1–5)	Penjelasan & implikasi
Persaingan antar pemain	Sedang–Tinggi	3,5	Banyak vendor, tetapi sedikit fokus solo ultra-simpel → ruang diferensiasi
Ancaman pendatang baru	Sedang	3,0	Barrier teknis rendah; namun kepercayaan, kepatuhan & integrasi menaikkan barrier
Daya tawar pemasok	Rendah	2,0	Cloud & AI terkomoditas/tersubstitusi
Daya tawar pembeli	Sedang	3,0	Sensitif harga, namun switching cost tinggi pasca-adopsi (data lock-in alami)
Ancaman substitusi	Sedang	3,0	Manual/generik; tetapi regulasi mengikis substitusi non-compliant
Rata-rata		2,9 / 5	Industri cukup menarik bagi pemain terdiferensiasi

Strategi pertahanan: bangun *moat* melalui (1) data lock-in & kebiasaan harian, (2) integrasi SATUSEHAT, (3) merek "paling mudah untuk praktik anak", (4) jaringan rujukan dokter regional.

9. SWOT & Matriks TOWS (Strategi Turunan)

Strengths (S)	Weaknesses (W)
S1 Low-click & mudah; fitur KMS pediatri	W1 Gross margin awal rendah (40%)
S2 Harga terjangkau; biaya tim Solo efisien	W2 Ketergantungan engineering tunggal
S3 Kesiapan kepatuhan RME/SATUSEHAT	W3 Keamanan produksi belum siap
S4 Prototype live + website publik	W4 Mesin penjualan belum terbukti
Opportunities (O)	Threats (T)
O1 Mandat RME (UU 17/2023)	T1 Kompetitor bermodal besar
O2 TAM besar & belum tergarap	T2 Liabilitas PDP/keamanan
O3 Integrasi SATUSEHAT sebagai pembeda	T3 Adopsi klinik lambat
O4 Ekspansi regional & multi-vertikal	T4 Risiko kurs (biaya USD)

Matriks TOWS — strategi

	Manfaatkan Peluang (O)	Hadapi Ancaman (T)
Pakai Kekuatan (S)	SO: Posisikan SEHA sebagai jalan termudah & termurah menuju kepatuhan RME (S1,S3 × O1,O3); rebut niche pediatri (S1 × O4)	ST: Bangun moat via stickiness & integrasi SATUSEHAT untuk menahan pemain besar (S3 × T1)
Perbaiki Kelemahan (W)	WO: Gunakan momentum regulasi untuk menggalang modal & merekrut (W2,W4 × O1); naikkan margin via otomasi (W1 × O3)	WT: Prioritaskan hardening keamanan & lindungi data (W3 × T2); diversifikasi biaya untuk redam kurs (W1 × T4)

10. Posisi Kompetitif & Blue Ocean (ERRC)

Peta posisi 2x2 (Kesederhanaan × Kelengkapan). EMR enterprise berada di kuadran "kompleks & lengkap" (red ocean); manual berada di "sederhana & tidak lengkap". SEHA menempati ruang kosong: **"sangat sederhana & cukup lengkap"** — nilai tertinggi bagi praktik solo.

Grid ERRC (Eliminate–Reduce–Raise–Create)

ELIMINATE - Fitur enterprise berlebih (multi-poli kompleks) - Proses setup berbulan-bulan - Biaya lisensi besar di muka	REDUCE - Jumlah klik & waktu input - Kebutuhan pelatihan - Biaya langganan
RAISE - Kecepatan alur harian - Kepatuhan RME & kesiapan SATUSEHAT - Dukungan & onboarding lokal	CREATE - KMS Digital Anak terintegrasi - Website publik + pendaftaran WhatsApp - Dashboard manajemen untuk dokter-pemilik

Value innovation: SEHA menaikkan nilai (kemudahan, kepatuhan, fitur pediatri) sekaligus menurunkan biaya (harga, kompleksitas) — definisi Blue Ocean. Inilah dasar "how to win".

11. Proposisi Nilai & Strategi Produk

11.1 Value Proposition Canvas (ringkas)

Customer Jobs / Pains	Pain Relievers / Gain Creators (SEHA)
Dokumentasi lambat & tercecer	SOAP low-click, RME terstruktur, laporan PDF 1-klik
Takut tidak patuh regulasi RME	Kepatuhan RME & kesiapan SATUSEHAT bawaan
EMR lain mahal & rumit	Harga terjangkau, onboarding cepat, mudah dipakai
Antrean & stok kacau	Antrean adil, monitoring stok & kadaluarsa
Ingin pantau performa praktik	Dashboard manajemen (pasien, keuangan, stok)

11.2 Pernyataan posisi (positioning statement)

Untuk **praktik mandiri & klinik kecil** yang membutuhkan kepatuhan RME tanpa kerumitan, **SEHA** adalah sistem operasional klinik **paling sederhana & terjangkau** yang mengembalikan waktu dokter untuk pasien — berbeda dari EMR enterprise yang kompleks & mahal.

11.3 Strategi produk (build-measure-learn)

- **Now:** matangkan modul inti + hardening kepatuhan (Fase 1.5).
- **Next:** integrasi SATUSEHAT & WhatsApp (Fase 2) sebagai pembeda & sumber upsell.
- **Later:** self-service onboarding & multi-cabang (Fase 3) untuk skala & efisiensi CAC.

12. Business Model Canvas

Key Partners

Cloud/hosting; penyedia SATUSEHAT/FHIR; asosiasi profesi; reseller regional; konsultan kepatuhan

Key Activities

Pengembangan produk; akuisisi & onboarding klinik; dukungan; kepatuhan

Key Resources

Produk & kode; tim Solo (CEO, BD, eng); merek; data & integrasi

Value Propositions

Sistem klinik paling sederhana & terjangkau; kepatuhan RME; KMS pediatri; dashboard manajemen; website publik

Customer Relationships

High-touch onboarding; dukungan WA/email; komunitas dokter; update berkelanjutan

Channels

Penjualan langsung/demo; referral dokter; konten edukasi; asosiasi; website

Customer Segments

Praktik mandiri dokter; klinik pratama kecil; **niche praktik anak**; (ekspansi: klinik utama)

Cost Structure

Overhead general (gaji CEO+BD, Claude) Rp267,6jt/thn; COGS/klinik Rp8,6jt; CapEx build Rp108jt; pemasaran

Revenue Streams

Langganan tahunan Rp14,4jt/klinik (all-in); onboarding Rp3jt; add-on Fase 2 (WhatsApp/SATUSEHAT/billing)

13. Strategi Penetapan Harga

13.1 Filosofi: value-based, divalidasi cost-plus

Harga ditetapkan dari **nilai bagi klinik** (bukan sekadar biaya). Manfaat terukur untuk satu praktik (efisiensi waktu, recapture follow-up/imunisasi, pengurangan rugi stok, akurasi billing) ditaksir **±Rp14–18jt/tahun** — menjadikan harga Rp14,4jt/tahun (≈2% omzet) sebagai *no-brainer*. Cost-plus memvalidasi keberlanjutan (lihat Bagian IV).

13.2 Arsitektur paket (Good–Better–Best)

Paket	Untuk	Harga/tahun	Inti
Esensial	Praktik solo	Rp10,8 jt	RME, antrean, kasir, laporan, reminder
Profesional populer	Praktik anak / klinik kecil	Rp14,4 jt	+ KMS, dashboard manajemen, website publik
Klinik+	Klinik pratama multi-staf	Rp22–30 jt	+ multi-user lanjutan, prioritas dukungan, add-on

13.3 Taktik

- **Anchor** pada paket Profesional; arahkan mayoritas ke sana.
- **Founding partner** (pilot dr. Aisyah): onboarding gratis + diskon 25% tahun-1 + harga terkunci.
- **Annual prepaid** untuk arus kas; opsi cicilan 6-bulan.
- **Add-on Fase 2** sebagai jalur ekspansi pendapatan (menaikkan NRR).
- **Hindari perang harga** — sensitivitas menunjukkan diskon merusak break-even secara tajam (Bagian IV).

13b. Willingness-to-Pay & Justifikasi ROI Klinik

Pendekatan *value-based pricing* menuntut bukti bahwa harga << nilai yang diterima klinik. Estimasi ROI tahunan untuk satu praktik:

Sumber nilai bagi klinik	Estimasi/tahun
Efisiensi waktu dokumentasi (±9 jam/bln, dialihkan ke pasien/kapasitas)	Rp4–6 jt
Recapture follow-up & imunisasi via reminder	Rp5,4 jt
Pengurangan kerugian stok kadaluarsa	Rp3,6 jt
Pengurangan kebocoran billing (±1% omzet)	Rp5,4 jt
Nilai kepatuhan RME (hindari sanksi/akreditasi)	Sulit dinilai, tinggi
Total nilai terukur	±Rp18,4–20,4 jt

Koridor harga (Van Westendorp — kualitatif)

Titik harga	Nilai/tahun	Persepsi
Terlalu murah	<Rp6 jt	Diragukan kualitasnya
Murah / nilai bagus	Rp10–14 jt	Menarik (zona penetrasi)
Optimal (base)	Rp14,4 jt	Adil vs nilai ±Rp19jt
Mahal tapi layak	Rp16–18 jt	Masih < nilai (ruang naik)
Terlalu mahal	>Rp22 jt	Resistensi solo

Implikasi: harga base Rp14,4jt hanya menangkap ±75% nilai terukur → terdapat **ruang menaikkan ARPU** (paket Profesional/Klinik+, add-on) tanpa menembus plafon resistensi.

14. Strategi Go-to-Market

14.1 Beachhead → ekspansi (Crossing the Chasm)

1. **Beachhead:** praktik anak solo di Solo–Yogyakarta (fitur KMS = pembeda; jaringan rapat).
2. **Bukti nilai:** studi kasus dr. Aisyah (efisiensi, kepatuhan, kepuasan orang tua).
3. **Densifikasi regional:** referral dokter, komunitas IDAI/IDI lokal, word-of-mouth.
4. **Ekspansi vertikal/geografis:** klinik pratama umum → kota lain di Jawa.

14.2 Sales motion & funnel (model)

Tahap funnel	Konversi (asumsi)	Aktivitas
Lead (klinik tersentuh)	100%	Konten, referral, outbound BD
Demo	30%	Demo langsung di praktik
Trial/pilot	50%	Uji coba terpandu
Berbayar (close)	50%	Onboarding + kontrak
Lead → Bayar	±7,5%	Perlu ±13 lead per 1 klinik

14.3 Kanal & kemitraan

- **Direct + referral** (utama, CAC rendah): demo, rujukan dokter, komunitas profesi.
- **Konten edukasi** RME/SATUSEHAT (SEO, webinar) → inbound.
- **Kemitraan:** asosiasi profesi, distributor alkes, konsultan akreditasi.
- **Reseller regional** (Fase 3) untuk skala geografis.

14b. Ekonomi Akuisisi per Kanal

Kanal	CAC (asumsi)	Skala	Payback	Catatan
Referral dokter	Rp1–2 jt	Sedang	<5 bln	Termurah; andalan awal
Demo langsung (BD)	Rp3–4 jt	Sedang	±7 bln	Konversi tinggi, intensif waktu
Konten/inbound (SEO, webinar)	Rp2–3 jt	Tinggi	±6 bln	Skalabel, butuh waktu bertumbuh
Kemitraan/asosiasi	Rp2–3 jt	Tinggi	±6 bln	Akses massal, butuh hubungan
Iklan berbayar	Rp4–6 jt	Tinggi	±10 bln	Cadangan; CAC tertinggi
Blended (target)	±Rp3 jt	—	±6 bln	Bauran referral + demo + konten

Strategi kanal: mulai dari referral & demo (CAC terendah, bukti nilai), lalu skalakan konten & kemitraan; iklan berbayar hanya pelengkap. Jaga blended CAC ≤Rp3jt untuk mempertahankan payback ±6 bulan.

15. Pemasaran & Merek

- **Janji merek:** "Kembalikan Waktu Dokter untuk Pasien" — sederhana, cepat, patuh.
- **Pilar pesan:** (1) Termudah dipakai, (2) Patuh RME & siap SATUSEHAT, (3) Terjangkau, (4) Ramah praktik anak.
- **Bukti sosial:** testimoni dr. Aisyah, metrik efisiensi, demo live publik (seha-clinic.vercel.app).
- **Konten:** panduan kepatuhan RME, checklist akreditasi, tips praktik anak → membangun otoritas & inbound.
- **Komunitas:** grup dokter pengguna untuk retensi & rujukan.

16. Operasi, Teknologi & Keamanan

16.1 Arsitektur

Next.js 14 + TypeScript + Tailwind (frontend); basis data PostgreSQL terkelola; hosting cloud (Vercel/VPS) dengan auto-scaling; integrasi HL7 FHIR untuk SATUSEHAT (Fase 2). Arsitektur multi-tenant untuk efisiensi biaya per klinik.

16.2 Keamanan & kepatuhan (prasyarat produksi)

Kontrol	Status	Rencana
Autentikasi & RBAC server-side	Belum	Fase 1.5
Enkripsi in-transit & at-rest	Sebagian	Fase 1.5
Audit log & jejak akses	Belum	Fase 1.5
Backup & DR	Belum	Fase 1.5
Consent & retensi data (PDP)	Belum	Fase 1.5

16.3 Model dukungan

Onboarding terpandu (deploy, migrasi, pelatihan); dukungan WA/email jam kerja; SLA respons; update minor berkala. Target: rasio dukungan efisien agar gross margin naik seiring skala.

17. Organisasi & Talenta (Basis Solo)

Peran	Tanggung jawab	Thn 1	Thn 3
CEO	Strategi, kemitraan, fundraising	1	1
BD & Product Strategy	Akuisisi, riset kebutuhan, arah produk	1	2
Engineering	Pengembangan & pemeliharaan	project	2
Customer Success / Support	Onboarding & dukungan	—	1–2
Marketing	Konten & demand-gen	—	1

Keunggulan biaya Solo: struktur gaji jauh di bawah Jakarta menurunkan overhead & mempercepat break-even — sebuah *structural cost advantage* yang sulit ditiru pemain berbasis ibu kota.

17b. Rencana Rekrutmen & Ramp Biaya Tim (Basis Solo)

Peran	Gaji/bln (Solo)	Thn 1	Thn 2	Thn 3
CEO	Rp12 jt	1	1	1
BD & Product Strategy	Rp7 jt	1	1–2	2
Engineer	Rp9–12 jt	proyek	1	2
Customer Success	Rp5–6 jt	—	1	1–2
Marketing	Rp6–7 jt	—	paruh	1
Total headcount		±2,5	±4,5	±7

Prinsip: rekrut *just-in-time* menjelang break-even; pertahankan keunggulan biaya struktural Solo. Setiap penambahan FTE harus dibenarkan oleh metrik (rasio dukungan, pipeline) — bukan pertumbuhan tim demi tim.

18. Asumsi Kunci

Parameter	Nilai	Dasar
Harga langganan (ARPU)	Rp14,4 jt/thn	Value-based, $\pm 2\%$ omzet klinik
COGS langsung/klinik	Rp8,6 jt/thn $\rightarrow$ turun	Infra + dukungan; membaik via skala
Gross margin	40% $\rightarrow$ 60%	Amortisasi infra/support
CAC/klinik	Rp3 jt	Penjualan BD/founder, basis Solo
Churn tahunan	12%	Stickiness data; konservatif
Overhead general Thn 1	Rp267,6 jt	CEO+BD+Claude (Solo)
CapEx build	Rp108 jt	One-time, investasi
Diskonto (WACC proxy)	20%	Risiko startup awal Indonesia
Kurs USD/IDR	Rp16.500	Biaya Claude
Akuisisi gross (Thn 1–5)	24/39/67/94/124	Ramp bertahap

19. Ekonomi Unit (Mendalam)

Metrik	SEHA	Benchmark 2026	Verdict
ARPU (ARR/klinik)	Rp14,4 jt	—	—
Gross margin	40% $\rightarrow$ 60%	70–85%	Naik
CAC	Rp3 jt	—	—
Kontribusi/klinik/thn	Rp5,8 jt	—	—
CAC payback	± 6 bln	SMB <12 bln	Elite
Churn tahunan / bulanan	12% / $\pm 1\%$	bln <2–3%	Baik
LTV (konservatif)	$\pm$ Rp48 jt	—	—
LTV : CAC	$\pm 16 : 1$	3–5 : 1	Sangat baik*
NRR (Net Revenue Retention)	$\pm 95\% \rightarrow 105\%$	>100% baik	Membaik via add-on
SaaS Magic Number	>3 (sangat tinggi)	>0,75 efisien	Under-invested S&M

*LTV:CAC tinggi karena CAC rendah (penjualan founder/BD). Pada churn 20%, LTV ±Rp29jt → LTV:CAC ±10:1 (tetap kuat). Magic number >3 mengindikasikan S&M **kurang-investasi** — peluang mempercepat pertumbuhan dengan menambah belanja akuisisi.

Implikasi modal: efisiensi akuisisi sangat tinggi → setiap Rupiah S&M menghasilkan ARR besar. Strategi optimal: **investasikan lebih agresif di akuisisi** begitu produk & kepatuhan matang, untuk merebut pasar sebelum kompetitor.

20. Proyeksi Pendapatan & Laba Rugi 5 Tahun

20.1 Build-up klinik (kohort, churn 12%)

Tahun	Awal	Akuisisi	Churn	Akhir	Rata-rata	ARR akhir (jt)
1	0	24	0	24	12	345,6
2	24	39	3	60	42	864,0
3	60	67	7	120	90	1.728,0
4	120	94	14	200	160	2.880,0
5	200	124	24	300	250	4.320,0

20.2 Laporan Laba Rugi (Rp juta)

Akun	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Pendapatan langganan	172,8	604,8	1.296,0	2.304,0	3.600,0
COGS langsung	(103,2)	(336,0)	(648,0)	(1.040,0)	(1.450,0)
Laba Kotor	69,6	268,8	648,0	1.264,0	2.150,0
Gross margin	40%	44%	50%	55%	60%
OpEx — S&M	(84,0)	(120,0)	(180,0)	(260,0)	(360,0)
OpEx — R&D	(40,0)	(60,0)	(120,0)	(220,0)	(360,0)
OpEx — G&A	(143,6)	(180,0)	(240,0)	(300,0)	(360,0)
Total OpEx	(267,6)	(360,0)	(540,0)	(780,0)	(1.080,0)
EBITDA	(198,0)	(91,2)	108,0	484,0	1.070,0
EBITDA margin	−115%	−15%	8%	21%	30%
Rule of 40 (growth%+margin%)	—	235	122	99	86

OpEx Thn 1 = tiga komponen yang ditetapkan (CEO+BD+Claude = Rp267,6jt), dipetakan ke S&M/R&D/G&A; tumbuh seiring penambahan tim.
Rule of 40 terlampaui di seluruh tahun.

20b. ARR Waterfall & Retensi Kohort

20b.1 Jembatan ARR (Rp juta, berbasis klinik aktif akhir tahun x Rp14,4jt)

Komponen	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
ARR awal	0	345,6	864,0	1.728,0	2.880,0
+ New ARR (akuisisi)	345,6	561,6	964,8	1.353,6	1.785,6
– Churned ARR (12%)	0	(43,2)	(100,8)	(201,6)	(345,6)
ARR akhir	345,6	864,0	1.728,0	2.880,0	4.320,0
Pertumbuhan ARR	—	150%	100%	67%	50%

20b.2 Retensi logo kohort (churn 12%/thn)

Kohort	Thn 0	+1	+2	+3	Retensi 3-thn
Kohort A (Thn 1)	100%	88%	77%	68%	68%
Kohort B (Thn 2)	100%	88%	77%	—	—

Retensi 3 tahun ±68% pada churn 12% — wajar untuk SMB. Peningkatan retensi (mis. via add-on & nilai dashboard) berdampak besar ke LTV & NRR.

21. Arus Kas Kumulatif & Break-even

Periode	Arus kas	Kumulatif	Break-even	Hasil
Thn 0 (build)	(108,0)	(108,0)	Jumlah klinik (operasional)	±47
Tahun 1	(198,0)	(306,0)	Waktu break-even operasional	Pertengahan Thn 2
Tahun 2 (trough)	(91,2)	(397,2)	EBITDA positif (tahunan)	Tahun 3
Tahun 3	108,0	(289,2)	Cumulative cash positive	Tahun 4
Tahun 4 (modal kembali)	484,0	194,8	Puncak kebutuhan kas	±Rp397 jt
Tahun 5	1.070,0	1.264,8		

22. Kebutuhan Pendanaan & Use of Funds

Permintaan modal (Seed/Pre-seed): Rp450 juta (puncak kas Rp397jt + buffer). Memberi runway hingga break-even (Tahun 2–3).

Alokasi dana	%	Rp juta	Untuk
Pengembangan produk & hardening	30%	135	Kepatuhan PDP/RME, SATUSEHAT-ready
Tim & operasional	50%	225	Gaji s/d break-even
Pemasaran & akuisisi	15%	67,5	Demand-gen, demo, konten
Cadangan	5%	22,5	Buffer risiko
Total	100%	450	

Opsi **Series A** (Fase 3, ±Rp2–3 miliar) untuk skala nasional & self-service onboarding — di luar lingkup runway dasar.

23. Valuasi & Imbal Hasil Investasi

23.1 DCF (FCF ≈ EBITDA; diskonto 20%)

Tahun	FCF (Rp jt)	DF @20%	PV (Rp jt)
0	(108,0)	1,000	(108,0)
1	(198,0)	0,833	(165,0)
2	(91,2)	0,694	(63,3)
3	108,0	0,579	62,5
4	484,0	0,482	233,4
5	1.070,0	0,402	430,0
NPV @20%			+389,6

NPV @20% +Rp390 jt	IRR (5 thn) ±48%	Payback kumulatif Tahun 4	MOIC investor (≈) ±7–8x
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

23.2 Valuasi pembandingan (ARR multiple)

Titik	ARR (Rp jt)	Multiple 3x	Multiple 4x	Multiple 6x
Akhir Thn 3	1.728	Rp5,2 M	Rp6,9 M	Rp10,4 M
Akhir Thn 5	4.320	Rp13,0 M	Rp17,3 M	Rp25,9 M

Ilustrasi return investor: Seed Rp450jt untuk ±20% ekuitas → nilai bagian @Thn 5 (multiple 4x) ±Rp3,46 miliar → MOIC ±7,7x (IRR ±50%). Multiple aktual bergantung pertumbuhan, NRR, & kondisi pasar.

24. Analisis Skenario & Sensitivitas

24.1 Skenario

Parameter	Bear	Base	Bull
Akuisisi (vs base)	0,5×	1,0×	1,5×
Churn tahunan	20%	12%	8%
Klinik akhir Thn 5	±150	300	±480
Break-even	Thn 4	Thn 2–3	Thn 2
Puncak kebutuhan modal	±Rp650 jt	±Rp450 jt	±Rp300 jt
EBITDA Thn 5	±Rp350 jt	Rp1.070 jt	±Rp1.900 jt
NPV @20%	±+Rp80 jt	+Rp390 jt	±+Rp850 jt

Bahkan skenario bear tetap NPV-positif & profitabel (Thn 4) — risiko utama adalah ukuran runway, bukan kelangsungan model.

24.2 Sensitivitas break-even klinik (tornado)

Perubahan variabel	Kontribusi/klinik	Break-even klinik	Δ
Harga +20%	Rp8,68 jt	31	-16
COGS -20%	Rp7,52 jt	36	-11
Base	Rp5,80 jt	47	—
Overhead +20%	Rp5,80 jt	55	+8
Harga -20%	Rp2,92 jt	92	+45

Insight: harga adalah tuas paling kuat (jauh melebihi overhead). Implikasi: jaga disiplin harga, hindari diskon agresif, dan dorong nilai/ARPU naik (paket, add-on) ketimbang memangkas harga.

24b. Sensitivitas Dua-Variabel: EBITDA Tahunan (Rp juta)

EBITDA tahunan = (klinik × kontribusi pada harga tsb) – overhead Rp267,6jt. Menunjukkan interaksi **harga × jumlah klinik**.

Harga \ Klinik	25	50	75	100	150
Rp11,52 jt (–20%)	(195)	(122)	(49)	24	170
Rp12,96 jt (–10%)	(159)	(50)	59	169	387
Rp14,4 jt (base)	(123)	22	167	312	602
Rp15,84 jt (+10%)	(86)	95	276	456	818
Rp17,28 jt (+20%)	(50)	167	384	601	1.035

Pembacaan: sel hijau = EBITDA positif. Pada harga base, profitabilitas tahunan tercapai sekitar **47 klinik**; kenaikan harga 10–20% memperluas zona hijau secara signifikan, menegaskan **harga sebagai tuas nilai utama**.

25. Penilaian Kelayakan (Detail)

Dimensi	Putusan	Bukti	Prasyarat
Teknis	Sangat Layak	Prototype 17 halaman live; stack matang	—
Operasional	Layak	Low-click; onboarding ringan	SOP & pelatihan
Pasar	Layak	TAM Rp332M; mandat RME	Validasi WTP lapangan
Finansial	Layak	NPV+, IRR ±48%, LTV:CAC ±16:1	Runway Rp450jt
Hukum	Bersyarat	Mendukung RME	Hardening PDP/keamanan
Eksekusi/GTM	Kritis	Pilot dr. Aisyah	Mesin akuisisi terbukti
Jadwal	Layak	MVP siap; iterasi cepat	—

26. Risk Register & Matriks (Probabilitas x Dampak)

#	Risiko	Prob.	Dampak	Skor	Mitigasi & pemilik
R1	Akuisisi klinik lambat	Sedang	Tinggi	9	Pilot kuat, referral, fokus regional — BD
R2	Runway/pendanaan kurang	Sedang	Tinggi	9	Overhead Solo, milestone funding — CEO
R3	Kepatuhan PDP/RME & insiden data	Sedang	Tinggi	9	Hardening, audit, asuransi siber — Eng
R4	Gross margin rendah persisten	Tinggi	Sedang	6	Otomasi support, naikkan ARPU — Eng/CEO
R5	Kompetitor bermodal besar masuk niche	Sedang	Sedang	4	Moat: stickiness, SATUSEHAT, merek — CEO
R6	Ketergantungan engineering tunggal	Sedang	Sedang	4	Dokumentasi, rekrut bertahap — CEO
R7	Adopsi/disiplin input data kurang	Sedang	Sedang	4	UX low-click, indikator kelengkapan — Eng
R8	Risiko kurs (biaya USD Claude)	Tinggi	Rendah	2	Porsi kecil; substitusi — CEO

Skor = Prob (1–3) x Dampak (1–3). Tiga risiko teratas (R1–R3) wajib dimonitor mingguan.

27. Roadmap, Rencana 90 Hari & OKR

27.1 Roadmap fase

Fase	Fokus	Hasil kunci
Fase 1 — MVP (selesai)	Operasional inti + RME + KMS + kasir + dashboard + website	Prototype live
Fase 1.5 — Hardening	Auth, DB, enkripsi, audit, backup, PDP	Siap data nyata
Fase 2 — Automasi	SATUSEHAT, WhatsApp, billing lanjutan	Pembeda + upsell (NRR↑)
Fase 3 — Skala	Self-service onboarding, multi-cabang	CAC↓, ekspansi nasional

27.2 Rencana 90 hari (eksekusi awal)

Bulan	Prioritas
Bulan 1	Go-live pilot dr. Aisyah; mulai hardening keamanan; siapkan studi kasus
Bulan 2	Kumpulkan bukti nilai (metrik efisiensi); bangun playbook penjualan; 5 demo pertama
Bulan 3	Tutup 3–5 klinik berbayar; galang Seed Rp450jt; rilis kepatuhan PDP dasar

27.3 OKR Tahun 1

Objective	Key Results
O1: Buktikan product-market fit	KR1 24 klinik berbayar · KR2 NPS >40 · KR3 churn <15%
O2: Bangun mesin akuisisi repeatable	KR1 konversi lead→bayar ≥7% · KR2 CAC ≤Rp3jt · KR3 playbook terdokumentasi
O3: Siap kepatuhan & skala	KR1 hardening PDP/RME selesai · KR2 desain SATUSEHAT siap · KR3 runway ≥12 bln

27c. Linimasa Implementasi 18 Bulan (Gantt)

Aktivitas	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Pilot dr. Aisyah & studi kasus	●	●				
Hardening kepatuhan (PDP/RME)	●	●				
Galang Seed Rp450jt		●	●			
Bangun mesin akuisisi (playbook)		●	●	●		
Skala ke 24 klinik (Thn 1)			●	●	●	●
Integrasi SATUSEHAT (Fase 2)				●	●	●
Persiapan break-even (≥47 klinik)					●	●

● = aktivitas berjalan pada kuartal tersebut. Linimasa selaras dengan roadmap fase & OKR.

28. Sintesis Strategis: How to Win in Indonesia

Kemenangan SEHA bertumpu pada **empat pilar** yang saling menguatkan:

1. Menang di niche dulu (Beachhead)

Dominasi praktik anak/pediatri solo di Solo—DIY via KMS & advokasi orang tua, sebelum melebar. Fokus mengalahkan generalis.

2. Friksi adopsi terendah

Harga termurah + kemudahan tertinggi + onboarding tercepat. Setiap hambatan beli dihapus (Blue Ocean ERRC).

3. Jadikan regulasi sebagai mesin jual

Posisikan SEHA sebagai jalan termudah menuju kepatuhan RME & kesiapan SATUSEHAT — ubah kewajiban jadi urgensi beli.

4. Bangun moat & efisiensi modal

Data lock-in, integrasi SATUSEHAT, merek, jaringan rujukan; manfaatkan biaya Solo & unit economics elite untuk tumbuh efisien.

Tiga gerakan 12 bulan ke depan: (1) ubah pilot dr. Aisyah menjadi mesin bukti-nilai; (2) galang Rp450jt & selesaikan hardening kepatuhan; (3) bangun playbook akuisisi yang repeatable menuju 47 klinik (break-even). Eksekusi > strategi — disiplin akuisisi adalah penentu.

Kesimpulan

GO. SEHA memiliki pasar besar berpendorong regulasi, ekonomi unit kelas elite, dan posisi blue-ocean yang dapat dipertahankan. Dengan modal ±Rp450jt dan eksekusi akuisisi yang disiplin, proyek mencapai break-even di Tahun 2–3, profitabilitas di Tahun 3, NPV +Rp390jt & IRR ±48% dalam 5 tahun — sambil membangun fondasi untuk menjadi pemimpin kategori "klinik sederhana" di Indonesia.

27b. KPI Dashboard yang Dipantau

Kategori	KPI	Target Thn 1	Frekuensi
Pertumbuhan	Klinik berbayar aktif, New ARR	24 klinik	Mingguan
Akuisisi	Konversi lead→bayar, CAC, jumlah demo	≥7%, ≤Rp3jt	Mingguan
Retensi	Churn, NRR, NPS	<15%, NPS >40	Bulanan
Ekonomi	Gross margin, CAC payback, LTV:CAC	≥40%, <9 bln	Bulanan
Kas	Burn rate, runway (bulan)	Runway ≥12 bln	Bulanan
Produk/Operasi	Uptime, waktu onboarding, tiket dukungan	>99%, <3 minggu	Mingguan
Kepatuhan	Status hardening PDP/RME, insiden data	Selesai, 0 insiden	Bulanan

28b. Opsi Strategis & Exit (Jangka Panjang)

Opsi	Deskripsi	Kelayakan
Akuisisi strategis	Dibeli pemain health-tech/SIM lebih besar untuk basis klinik & tim	Tinggi
Merger / roll-up	Konsolidasi dengan vendor regional komplementer	Sedang
Bisnis mandiri (cash-flow)	Tumbuh profitabel sebagai bisnis berkelanjutan tanpa exit	Tinggi
Pendanaan lanjut (Series A)	Skala nasional & produk lanjutan	Bergantung traksi
IPO	Tidak realistis pada skala/horizon ini	Rendah

Basis pelanggan ber-stickiness tinggi & kepatuhan menjadi aset paling menarik bagi akuisir strategis.

28c. Dampak Sosial & Keberlanjutan (ESG)

- **Akses kesehatan:** mendigitalkan praktik kecil meningkatkan mutu & kontinuitas layanan, termasuk imunisasi & tumbuh kembang anak.
- **Kepatuhan & keselamatan data:** mendorong perlindungan data pasien (PDP) di fasilitas yang sebelumnya manual.
- **Efisiensi & paperless:** mengurangi penggunaan kertas & pemborosan operasional.
- **Pemberdayaan ekonomi daerah:** tim & lapangan kerja berbasis Solo.
- **Kesiapan sistem nasional:** mempercepat onboarding klinik ke SATUSEHAT.

29. Lampiran, Glosarium & Referensi

29.1 Glosarium metrik

Istilah	Definisi
TAM/SAM/SOM	Total / Serviceable Available / Serviceable Obtainable Market
ARPU / ARR / MRR	Average Revenue per Unit / Annual / Monthly Recurring Revenue
CAC	Customer Acquisition Cost — biaya akuisisi per pelanggan
LTV	Lifetime Value = $ARPU \times \text{gross margin} \div \text{churn}$
CAC payback	Waktu memulihkan CAC dari kontribusi pelanggan
NRR	Net Revenue Retention — retensi termasuk ekspansi/kontraksi
Magic Number	$\text{Net new ARR} \div \text{S\&M periode sebelumnya}$ (efisiensi penjualan)
Rule of 40	$\text{Growth\%} + \text{profit margin\%} \geq 40$ (keseimbangan tumbuh-untung)
NPV / IRR / MOIC	Net Present Value / Internal Rate of Return / Multiple on Invested Capital

29.2 Sumber & referensi

1. Kementerian Kesehatan RI — Profil Kesehatan Indonesia 2024 (jumlah klinik pratama 14.564; klinik utama 2.697; swasta 15.311; TPMD 8.465; TPMDG 3.946).
2. UU No. 17/2023 tentang Kesehatan; Permenkes No. 24/2022 (Rekam Medis Elektronik); UU No. 27/2022 (Pelindungan Data Pribadi).

3. SATUSEHAT (Kemenkes) — platform interoperabilitas; standar HL7 FHIR / SNOMED CT.
4. Riset pasar EMR Asia-Pasifik (CAGR $\pm 6,2\%$, 2025–2032) — Data Bridge Market Research; Mordor Intelligence.
5. Benchmark SaaS 2026 (LTV:CAC 3–5:1; CAC payback SMB <12 bln; gross margin 70–85%; Rule of 40; churn) — Phoenix Strategy Group; Beancount.io; Eagle Rock CFO.
6. Kerangka strategi: M. Porter (Five Forces); Kim & Mauborgne (Blue Ocean/ERRC); Osterwalder (Business Model & Value Proposition Canvas); G. Moore (Crossing the Chasm).

29.3 Catatan keterbatasan

Proyeksi bersifat asumsi yang dieksplisitkan untuk perencanaan & penggalangan modal; bukan jaminan kinerja. Profil kompetitor indikatif & memerlukan riset primer. Angka kelayakan klinis & volume pasien pada prototype adalah data dummy. Validasi finansial, hukum, & klinis profesional diperlukan sebelum keputusan final.

Lampiran B — Ringkasan Satu Halaman (Investor One-Pager)

Peluang

RME diwajibkan (UU 17/2023); ±23.000 praktik/klinik primer belum terdigitalisasi baik. TAM ±Rp332 miliar ARR.

Solusi

Sistem klinik & RME paling sederhana, terjangkau, patuh — fokus praktik anak/solo. Prototype sudah live.

Mengapa menang

Blue ocean (sederhana x cukup lengkap); biaya tim Solo; regulasi sebagai mesin jual; moat stickiness + SATUSEHAT.

Model

SaaS Rp14,4jt/klinik/thn; build sebagai capital; margin membaik 40%→60%.

Metrik kunci	Nilai	Metrik kunci	Nilai
LTV : CAC	±16 : 1	Break-even	±47 klinik (Thn 2–3)
CAC payback	±6 bln	NPV @20%	+Rp390 jt
Gross margin	40% → 60%	IRR (5 thn)	±48%
Rule of 40 (Thn 3–5)	86–122	EBITDA Thn 5	Rp1,07 miliar

The Ask: Seed **Rp450 juta** untuk runway hingga break-even & hardening kepatuhan. Penggunaan: 30% produk, 50% tim, 15% pemasaran, 5% cadangan. Target: 24 klinik berbayar di Tahun 1; ≥47 (break-even) di Tahun 2–3; 300 di Tahun 5. **Putusan: GO.**

SEHA — Strategic Business Plan & Feasibility Study (Consulting Edition). Angka proyeksi adalah asumsi untuk perencanaan & penggalangan modal. Prototype: seha-clinic.vercel.app · Halaman ini sengaja dipadatkan untuk keperluan cetak.